

HYPERTROPHIE BENIGNE DE LA PROSTATE

Dr RABEMANANTSOA Tahiry

INTRODUCTION :

- **Prostate** : glande, nutrition, sperme et éjaculation
- **HBP ou adénome de la prostate** :
 - o **= prolifération bénigne (partie centrale prostatique)** (=zone de transition)
 - o Différent de cancer en périphérie ou queue de la prostate
- **Hypertrophie** → une **obstruction** cervico-urétrale
- **Très fréquente** chez un homme de plus de 50 ans
- Tumeur d'organe sexuel à répercussion urinaire
- Tumeur hormono-dépendante (testostérone)

RAPPEL ANATOMIQUE :

ANATOMO-PATHOLOGIE :

Aspect :

- **Poids** : 50 – 100 g en moyenne
- **Bilobée** (gauche et droite) +/- lobe médian, sillon médian
- **Encapsulé** = possibilité d'énucléation

Siège :

- Au niveau de la **zone de transition = zone centrale**

Evolution anatomique :

- **Compression** de l'urètre prostatique **sans envahissement**
- « Œuf dans son coquetier »
- *Plus l'âge évolue, plus le risque est élevée*

Pas de parallélisme anatomo-clinique (pas de signe même si augmentation de volume = 0 enlèvement : et même si petite volume mais avec signes = prise en charge=

EPIDEMIOLOGIE :

Fréquence :

- **Prévalence** augmente avec l'âge
- 8% à 30ans, 40% à 50 ans et 80% à 80ans
- **Tous font une HBP s'ils vivent assez longtemps**
- Tendance vers l'**aggravation**
- **Une partie** nécessite un **acte chirurgicale**

Facteurs favorisants :

- **Testicules fonctionnels + âge suffisant**
- Facteurs non prouvés :
 - o Habitudes alimentaires

- Comportement sexuel
- Tabac
- **Race asiatique** : facteur protecteur
- **Aucun lien entre HBP et cancer de la prostate** → les 02 maladies peuvent coexister

PHYSIOPATHOLOGIE :

Glande hormono-dépendante (testostérone) :

- **Existence de testostérone** → **hypertrophie bénigne de la prostate**
- **Castration** : agénésie, atrophie prostatique
- **Administration d'hormone** : reprise du développement
- De la naissance à la puberté → augmentation du volume plus de 25g sous l'action de DHT (dihydrotestostérone)
- **Age adulte : hypertrophie** pour des **raisons NON CONNUES**

Dyssynergie mictionnelle :

- **La miction normale = bonne synergie entre les forces d'expulsion des urines** (contraction vésicale) **et de rétention** (sphincters)
- L'adénome de la prostate entraîne des **modifications** :
 - **Anatomiques**
 - **Urodynamiques** du bas fond vésical (*embouteillage des urines, diminution du débit urinaire*)
 - Et de **l'urètre**
- ⇒ **Perturbation de la miction** (dyssynergie)

Hypertrophie :

- **En périphérie** : asymptomatique
- **Vers la vessie** : signes irritatifs
- **Vers l'urètre** : signes obstructifs
- ⇒ **Retentissement vésical – retentissement rénal**
- **Causes des accidents rétentionnels** :
 - **Voyage assis prolongée, congestion du pelvis** (compression périnéale → exacerbation de la compression urétrale de l'HBP)
 - **Médicaments** : atropine, Ephédrine
 - Absorption **d'alcool, infection urinaire** (*toute infection urinaire chez l'homme est grave !!!*)

DIAGNOSTIC POSITIF :

Interrogatoire :

- Élément fondamental
- Les **antécédents** et **traitements suivis**
- Les **complications** éventuelles
- Les éléments de **gravité**
- **Trouble mictionnel** : SBAU « syndrome du bas appareil urinaire »+++
 - **Signes irritatifs** :
 - **Résidu post-mictionnel ???** (*dans la demande d'échographie : échographie de la vessie et de la prostate + RPM*)
 - **Irritation par prostate volumineuse**
 - Pollakiurie diurne de plus en plus importante
 - Pollakiurie nocturne de plus en plus fréquente

- Envie répété et impérieuse d'uriner
- Fuites urinaires par besoin
- Hématurie
- **Signes obstructifs** (obstacle d'évacuation)
 - **Dysurie d'attente** : retard d'apparition de la miction
 - **Dysurie de poussée** : faiblesse du jet, « pisser sur ses bottes »
 - **Miction allongée, interrompue**
 - **Gouttes retardataires**
 - **Rétention : mauvaise vidange** :
 - **Aiguë** : brutale et totale
 - **Chronique** : miction par regorgement (*misy globe vésical foana malgré mipipi*)
- **Signes d'inflammation pelvienne** :
 - **Brûlures** urétrales
 - **Pesanteur** pelvienne
 - **Périnéalgie**

Examen physique :

- **Etude de la miction (caractère du jet)**
 - Force du jet
 - Effort
 - Durée
 - Volume
 - Couleurs des urines
- **Toucher rectal +++ SLIPR = HBP**
 - Augmentation du volume prostatique
 - **Indolore**
 - **Régulière**
 - **Lisse et souple** « balle de tennis »
 - **Effacement du sillon médian**
 - Si **normale** → **diagnostic non écarté**
 - **Élimine le cancer et la prostatite**
- **Examen général** :
 - **Globe vésical** (rétention d'urine) (douloureuse + envie d'uriner lors de la palpation)
 - **Gros rein** distendu (hydronéphrose)
 - **Hernie** de faiblesse
 - **Autres appareils**

Examens complémentaires :

- **Jamais sans passer par TR**
- **Biologie** :
 - **Standard** (retentissement)
 - **PSA** (élimine cancer)
 - **ECBU** (stase = infection)
- **Echographie** :
 - **Sus-pubienne** : prostate, résidu, reins
 - **Endo-rectale** : précision d'image, biopsie
- **Débitmétrie urinaire** :
 - Débit maximal
 - Temps de miction

- Volume mictionnel
- Aspect courbe
- **Urétrocystoscopie :**
 - **Obstruction** par prostate
 - **Lésion vésicale associée :** signes irritatifs +++
- **UIV, cystographie :**
 - **Empreinte** prostatique
 - **Calcul**
 - **Diverticules**
 - **Hydronéphroses**

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL :**Signes obstructif et grosse prostate au TR :****Prostatite :**

- Inflammation d'origine infectieuse
- Tableau d'adénome
- Signes infectieux
- Augmentation de la prostate
- Douloureuse
- Succulente
- Ramollie avec nodule

Cancer de la prostate :

- Tableau d'adénome, PSA augmentée (> 4ng)
- Prostate dure
- Nodule
- Pierreuse
- Biopsie +++

Signes obstructifs et TR normal :**Maladie du col :**

- Sclérose du col vésical
- Jeune
- Tableau d'adénome

Sténose urétrale :

- Antécédent infectieux
- Traumatisme urétral
- Urétrocystographie rétrograde et mictionnel : UCRM

Signes irritatifs :**Tumeur vésicale :**

- Hématurie totale

- Cytologie (cellule maligne urothéliale)
- Cystoscopie et biopsie

Infection urinaire :

- ECBU

Maladies neurologiques :

- Sans obstruction
- Sujet jeune
- Trouble de l'éjaculation
- Dysfonction érectile (impuissance)

EVOLUTION :

- **Asymptomatique :**
 - o Longtemps stationnaire : rare
 - o Ou troubles mineurs
- **Symptomatique :**
 - o Recours à la chirurgie

COMPLICATIONS :**Mécaniques :**

- **RAU** peut être inaugurale → **URGENCE** car pisser ou mourir
- **Diverticules** : faiblesse de la paroi vésicale (vessie de lutte) (reste même en post-op)
- **Calcul** : stase et infection → *agrégation de produits lithogène*
- **Hématurie** : rupture de veines péri-prostatiques (dans les poussées)
- **Urétérohydronéphrose** : distension des voies urinaires hautes (douleur : colique néphrétique) → IR
- **Hernie inguinale** de faiblesse souvent bilatérale (*opération sans toucher la prostate → hernie récidivante*)
- **Prolapsus rectal** et **hémorroïdaires** dues aux poussées
- (si refus opératoire → sonde vésicale pour éviter la stase urinaire, hydronéphrose, IR)

Infectieuses :

- **Prostatite**
- **Adénomite**
- **Orchite**
- **Infections urinaires** (basses → pyélonéphrite)
- **Septicémie**
⇒ **URGENCE THERAPEUTIQUE**

TRAITEMENT :**Buts :**

- Réduire les gênes et symptômes
- Diminuer l'obstruction
- Enlever l'adénome

- Traiter les complications

Moyens :

- **Surveillance** et **conseil hygiéno-diététique**

Médicaments :

- **Phytothérapie** : serenoa repens (Permixon 160), pygeum africanum (Tadenan 50)
- **Inhibiteur 5- α -réductase** : Finastéride (Chibro-proscar 5)
- **α -bloqueur** : Alfuzosine (Xatral LP10 ou 5)
- **Association** inhibiteur 5- α -réductase et α -bloqueur (Dutasun plus)

Chirurgie :

- **Endoscopique** :
 - o **Résection endoscopique** : TURP (unipolaire ou bipolaire) (*ita ihany no misy et Mada*)
 - o Incision cervicoprostatique, HOLEP (énucléation par laser)
- **Chirurgie ouverte** : adénomectomie par voie haute
 - o **Trans-vésicale** de FREYER ou HRINTSCHAK (+/- abandonné) (énucléation de la prostate en passant par la vessie)
 - o **Rétro-pubienne** de MILLIN

Indications :

- **Tenir compte de** :
 - o Âge
 - o Etat général
 - o Gêne ou qualité de vie
 - o Effets secondaires du traitement
 - o Possibilité financière et choix du patient +++
- **HBP sans gêne** : surveillance, hygiène de vie
- **Gêne modérée** : traitement médicamenteuse
- **Gêne ++, compliquée, réponse médicale ???**
 - o Traitement chirurgicale
 - o Résection 1g/min
 - o < ou = 30 g : incision cervicoprostatique
 - o Plus de 30 g : TURP
 - o Si volumineuse : chirurgie ouverte

Résultats :

- **Médicaments** : améliorations des signes urinaires, continu ou non

Surveillance :

- **Réponse au traitement médicamenteux** :
 - o Amélioration de la gêne : miction, débitmétrie,...
 - o Ejaculation précoce, gynécomastie
- **Chirurgie** : caillottage, dysurie, cancer ??, drains, sonde

CONCLUSION :

- Tumeur bénigne fréquente de vieillards

- Clinique et évolution variable
- Obstacle à l'évacuation vésicale
- Bonne prise en charge :
 - o Sinon : retentissement rénal bilatéral
 - o Association possible avec cancer → histologie de la pièce opératoire

Complications infectieuses de HBP : RAU + HBP + douleurs mictionnelles + polynucléose + syndrome inflammatoire